

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

현장 응급처치 관리 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001_도입에 따른 신규 제정	남보현	강동현	박응민
2	2023.01.16	개정	사내 표준문서 관리규정 변경 및 조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	박응민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	박응민
4	2025.01.03	개정	감염병 예방 지침서와 별도	류은아	강동현	박응민

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

			구분됨에 따른 개정			
5	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재 해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 행동수칙
- 7 7 응급처치의 시행
- 8 8 기록 및 보관
- 9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	3 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 지침은 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)의 모든 근로자에 대하여 재해자의 현장 응급처치(이하 "응급처치"라 한다)를 위한 준비사항과 시행 원칙을 제시하고 응급상황 시 대응 절차와 조치사항을 규정한다.

2 2 적용범위

본 지침은 재해자 응급처치가 필요한 응급상황 시 모든 사업장에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

4.1 "응급처치"라 함은 사고나 질병으로 갑자기 재해자가 발생하였을 때 그 재해자가 의료기관에 도착하기 전까지 행해지는 즉각적이고 임시적인 처치를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	4 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4.2 “재해자”라 함은 업무에 기인하거나 또는 업무와 관계없는 사고나 질병으로 인하여 사망 혹은 부상하거나 위급한 상황에 처한 자를 말한다.

4.3 “응급상황”이라 함은 생명이나 건강에 심각한 위협을 주며 신속한 대응이 필요한 상태를 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 안전보건관리(총괄)책임자는 재해 발생시 현장에서 구조, 관리 및 응급처치활동을 지휘할 책임자를 지정해야 한다.

5.2 관리감독자는 산업재해에 대한 보고 및 응급처치의 의무가 있다.

5.3 안전보건팀은 사업장 순회점검, 지도, 관리 및 조치의 건의 의무가 있다.

5.4 안전보건관리(총괄)책임자는 인근의 의료기관과 119구급대 및 사업장을 포함하여 지역단위의 상호협력체계를 구축하여야 한다

5.5 관리감독자는 사업장 인근 의료기관의 응급처치능력에 대하여 다음의 정보를 파악하여야 한다.

5.5.1 의료기관의 주소와 전화번호

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

5.5.2 규모 및 특별한 분야의 치료능력, 진료시간, 이송거리 등

5.6 계획의 수립

5.6.1 안전보건팀은 응급상황, 재난발생에 대비한 행동계획을 수립 시 아래의 사항이 포함되어야 한다.

- 위생, 청결 물품 확보 방안(손 세정제, 마스크, 체온계, 티슈, 청소 물품 등)
- 화상, 질식, 추락, 심정지 등 응급상황의 종류
- 근로자의 수, 응급처치 수행자격 보유자 등 인력현황
- 전화, 무전기, 비상등, 소화기, 응급구조 장비 등 비상시 사용물품 현황

5.6.2 안전보건관리(총괄)책임자는 부상자의 응급처치에 필요한 다음의 구급용구를 비치하고 장소와 사용방법을 근로자에게 널리 알려야 한다. 또한 재난 발생 시 상황에 따라 상황 업무를 담당하고 대응계획을 수립하여 시행한다.

- 붕대재료, 탈지면, 핀셋 및 반창고, 외상에 대한 소독약, 지혈대, 부목 및 들것

6 6 행동 수칙

6.1 신속한 연락과 처치

6.1.1 현장응급처치 시행자는 시행자에 의한 1차 처치가 4분 이내에 이루어지고 전문가에 의한 처치가 8분 이내에 이루어 질 수 있도록 의료기관이나 119 구조대에 연락하고 신속하게 처치한다.

6.1.2 응급처치기구가 없으면 주변의 물건을 이용하여 응급처치를 시행한다. 응급처치 교육·훈련은 외부 전문기관 위탁교육, 사내 집체교육, 심폐소생술·자동심장충격기(AED) 실습, 온라인 교육 등 중에서 사업장의 인원구성과 근무형태에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 실시할 수 있다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	6 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.2 응급처치에 대한 허락

6.2.1 재해자가 의식이 있으면 응급처치를 시행해도 좋다는 허락을 받아야 한다.

6.2.2 의식이 없는 경우에는 동행인에게 허락을 받고 동행인이 없으면 허락을 받은 것으로 간주한다.

6.3 추가 손상의 방지

6.3.1 더 이상의 손상을 방지하기 위하여 의식이 없는 재해자와 경추(목뼈)와 척추 손상이 의심되는 재해자의 이송과 처치 시에 경추보호대와 전신부목으로 고정하여 보호한다.

6.3.2 응급처치방법을 정확히 모르면 재해자에게 처치를 시행하지 말고 상태를 관찰하며 전문가의 도착을 기다린다.

6.4 응급처치원 준수사항

6.4.1 처치원 자신의 안전을 확보한다.

6.4.2 환자나 부상자에 대한 생사의 판정은 하지 않는다.

6.4.3 원칙적으로 의약품을 사용하지 않는다. 어디까지나 응급처치로 그치며, 그 다음은 전문 의료요원의 처치에 맡긴다.

7 처치의 시행

7.1 1차조사 및 응급처치

7.1.1 재해자에게 접근하는 동안 안색, 출혈, 구토물 등 전체적인 상태를 관찰한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.1.2 재해자의 어깨를 두드리며 의식을 확인한다.

7.1.3 조사 도중 재해자의 의식이 없으면 즉시 119 구급대나 의료기관에 구조요청을 하고 주위에 도와줄 사람이 없으면 큰 소리로 도움을 요청한다.

7.1.4 구조요청 후 손가락 두 개로 턱을 들어 올리고 다른 손으로 고개를 뒤로 젖혀서 기도를 개방하고 입안에 구토물 등 이물질이 있으면 손가락으로 제거한다.

7.1.5 머리 부위에 외상이 있으면 경추 손상이 있을 것으로 간주하고 목의 움직임을 최소화 할 수 있도록 보호하며 기도를 개방한다.

7.1.6 응급처치 시 다음 각 호에 해당하는 경우에는 의료인 또는 응급 구조사에 한하여 시행한다.

- 맥박확인
- 인공호흡 실시
- 심폐소생술 실시

7.1.7 출혈이 심하면 직접 압박, 지혈점 지압, 지혈대법 등으로 지혈처치를 한다.

7.1.8 다음 각 호와 같이 쇼크의 증상이 나타나면 쇼크를 예방하기 위하여 발과 다리를 지면으로부터 15 ~ 30cm 정도 높이고 보온조치를 한다.

- 갈증과 불안함
- 약하고 빠른 맥박
- 불규칙하고 약한 호흡
- 창백한 안색
- 차갑고 축축한 피부
- 동공의 확대와 빛에 대한 반사 지연
- 구역질과 구토

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 점진적인 혈압 저하

7.2 2차조사 및 응급처치

7.2.1 재해자의 상태가 어느 정도 안정되어 있으면 호흡, 맥박, 체온을 다시 측정하여 정상과 비교한다.

7.2.2 재해자의 머리부터 발끝까지 동공의 상태, 맥박, 감각, 운동상태, 피부색, 통증 등 전반적인 상태를 평가하고 재해자나 주변 사람들로 부터 병력을 청취하는 등의 조사를 시행한다.

7.2.3 조사 후 지연 처치가 가능한 골절, 외상, 화상 등에 대한 처치를 시행한다.

7.3 구조요청 및 연락

7.3.1 응급상황 발생 시 의료기관 및 119구급대에 구조를 요청 할 때에는 다음 각 호의 사항을 유의하여 정보를 제공하여야 한다.

- 재해자의 수
- 재해자의 상태
- 응급처치의 내용
- 구조에 필요한 장비
- 재해자가 있는 장소의 정확한 위치
- 연락 가능한 전화번호 및 연락자 성명

7.3.2 재해자의 가족에게 연락 시에는 다음 각 호의 사항을 유의하여 연락한다.

- 재해자의 가족인지 확인
- 자신의 소속과 성명

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 재해자의 상태
- 재해자를 이송할 병원의 위치, 전화번호 등

7.3.3 주위에 다른 근로자가 있으면 구조자를 도와 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.

- 구급차 및 가족에게 연락
- 주변의 위험물 제거
- 응급처치 재료를 구비
- 보온을 위한 모포 등의 확보
- 응급처치의 보조
- 재해지역 및 군중의 통제

7.4 재해자의 안정

7.4.1 구조자는 재해자의 상태에 따라 다음 각 호와 같이 적합한 자세를 유지해야 한다.

- 재해자가 의식이 있으면 편하다고 하는 자세를 취해준다.
- 의식이 없이 엎드려 있다면 경추와 척추를 잘 지지한 후 통나무 굴리듯이 돌려 눕혀 바로 누운 자세를 취하여 준다.
- 안색이 창백하면 다리를 30° 정도 들어 올려주고 안색이 붉으면 상체를 비스듬히 높여 준다.
- 의식이 없는 재해자가 구토를 하면 고개를 옆으로 돌려 구토물이 기도로 넘어 가지 않게 한다.
- 일반적으로 출혈부위와 골절부위는 심장보다 높여 준다.
- 재해자가 의식이 있으면 불안해하지 않도록 안심시키고 응급처치 시행 중 자주 조용히

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	10 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

말을 건다.

- 재해자의 상태를 계속 관찰한다.
- 재해자의 처치와 안정에 방해가 되지 않도록 군중을 통제한다.

7.5 보온유지

7.5.1 재해자의 체온을 유지하기 위하여 모포나 옷을 덮어 준다.

7.5.2 재해자의 옷이 젖어 있으면 벗기고 마른 옷으로 갈아 입힌 후 보온조치를 취한다.

7.5.3 보온을 위한 모포나 마른 옷, 수건 등이 없을 때에는 신문지 등 주변에 있는 것을 덮어 준다.

7.6 수분공급

7.6.1 의식이 없는 재해자는 입으로 아무것도 먹이지 않아야 한다.

7.6.2 재해자가 의식이 있는 경우에도 출혈이 심하거나, 내출혈이 의심되거나, 병원 이송 후 수술 할 가능성이 있는 경우 등에는 음료수를 먹이지 않는다.

7.6.3 의식이 있으면 상온의 음료수를 수저로 떠먹이는 정도로 소량씩 먹인다.

7.6.4 의식이 있고 보온이 필요하다면 따뜻한 음료수를 먹인다.

7.6.5 땀을 많이 흘렸거나 설사 등에 의하여 탈수가 우려되는 재해자가 의식이 있으면 이온 음료수를 먹이거나 물에 소금과 설탕을 약간씩 타서 먹인다.

7.7 재해자의 이송

7.7.1 응급처치가 끝나면 다친 부위가 움직이지 않도록 이송장비에 고정한다.

7.7.2 이송장비나 재해자가 주변의 물체에 부딪히지 않도록 주의하면서 흔들리지 않게 조용히 이송한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	11 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.7.3 의식이 없는 재해자를 차량으로 이송할 때에는 운전자 외에 1인 이상의 구조자가 동승한다.

7.7.4 재해자를 이송하는 도중에 재해자가 더 이상의 손상을 입거나 기도가 막히지 않도록 응급처치 시행자는 재해자의 자세를 적절히 유지하고 상태를 계속 관찰하며 의료기관에 도착할 때까지 필요한 처치를 시행한다.

7.7.5 가능하면 처음부터 끝까지 경과를 잘 아는 최초의 구조자 및 응급처치 시행자가 동행하여 정확한 정보를 의료진에게 제공한다.

7.8 증거물의 보존

7.8.1 신체의 일부가 절단되었으면 절단물을 깨끗한 비닐봉지에 두 번 씌운 후 얼음에 직접 닿지 않게 얼음물에 담가 의료기관에 가지고 간다.

7.8.2 의료기관에서 진단과 치료를 하는데 참고가 될 수 있는 배설물, 구토물, 혈액이 묻은 옷, 남은 음식물,약품, 약봉투, 약품이나 기타 물질을 담았던 빈 용기, 소지품 등은 보존하여 의료기관에 제출한다.

7.8.3 증거물을 의료기관에 가지고 가지 못한 경우에는 증거물의 상태에 대한 자세한 정보를 제공한다.

7.8.4 자살이나 타살 등이 의심되는 경우에는 위의 증거물 외에 재해자가 쓰러진 위치, 방향, 주위 사물의 상태 등에 대한 세밀한 관찰과 보고가 필요하므로 현장을 보존한다.

7.9 기록과 보고

7.9.1 응급처치 시행자가 실시한 모든 처치는 가능하면 기록 · 보존하고 안전보건팀에 보고한다.

7.9.2 응급처치 기록은 재해자의 의료기관 이송 시 가지고 간다.

7.9.3 다수의 재해자가 동시에 발생하였을 경우 개개인에게 기록표를 붙인다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	12 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.9.4 기록을 하지 못하였을 경우에는 상황을 잘 기억하였다가 치료에 도움이 되는 사항을 의료진에게 구두로 설명한다.

8 8 기록 및 보관

양식번호	양식명	검토기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-019	제1호. 기본응급처치 방법	반기별	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-019	제2호. 환자 상태별 응급처치 요령	정책변경시 이슈발생시	

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 응급상황은 현장 안전확보, 의식·호흡 확인, 119 신고 및 가능한 범위의 응급처치를 우선하고 응급연락망과 AED 위치를 평소 확인한다.
- 폭염작업 중 두통·어지럼·근육경련·의식저하 등 온열질환이 의심되면 즉시 작업을 중지하고 시원한 장소로 이동시킨 후 지체 없이 119 신고 등 필요한 구호조치를 한다.
- 응급처치 후 사고·증상 발생경위와 조치내용을 기록하고 산업재해 조사, 위험성평가 및 재발방지대책과 연계한다.

9 9 부칙

이 지침서의 최초 시행은 2022년 03월 04일 이며, 개정본의 시행은 2025년 01월 03일로 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	13 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	사내 표준문서 관리규정 변경 및 조직 이동에 따른 개정	• 1항 목적 내용 추가 (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』에 따른 대응 절차 및 조치사항 규정) • 2항 감염병 확산으로 인한 위기상황 시 추가 • 4.3항 "감염병" 용어와 정의 추가 • 5.6항 계획의 수립 추가 (감염병 환자 발생 시 환자 현황 작성 및 관리/ 위생, 청결 물품확보방안/ 정부의 질병관리계획에 적 극협력) • 6.4항 응급처치원 준수사항 행동수칙 추가 • 6.5항 감염병 발생 시 준수사항 행동수칙 추가 • 작성부서 및 양식관리부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀 • 별첨 추가

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	14 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

3	23.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	• 기록 및 보관 추가 • 양식 검토기간 추가 - 반기별, 정부정책변경시 이슈발생시
4	25.01.03	개정	감염병 예방 지침서와 별도 구분됨에 따른 개정	• 1항 목적 내용 추가 및 삭제 (추가_응급상황 시, 삭제_ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』에 따른 감염병 발생으로 인한 위기상황) • 2항 적용범위 내용 추가 및 삭제 (추가_필요한 응급상황, 삭제_필요하거나 감염병 확산으로 인한 위기상황) • 4.3항 “응급상황” 정의 추가 • 5.6.1항, 5.6.2항 감염병 관련 내용 삭제 • 7항 응급처치의 일반적 원칙 전체 삭제 (6항 행동수칙과 내용 중복) • 별첨1. 내용 추가 “인공호흡은 시행 방법을 모르거나 꺼려지는 경우 생략 가능” • 각항의 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자 수정 → 안전보건(총괄)책임자

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	15 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별첨 제 1호. 기본응급처치 방법)

구분	응급처치 세부요령
구조 및 응급 처치 절차	1. 의식유무 확인 2. 도움요청 3. 환자자세 교정 위로 보도록 바로 눕힌다.(1, 2, 3항이 10초 이내에 이루어져야 한다.) 4. 기도개방 (머리 뒤로 젖히기/턱 끌어올리기) 한 손을 환자의 이마에 대고 뒤로 밀어 머리가 젖혀지게 하고 다른 손으로는 턱 밑의 오목한 뼈 부분을 위로 끌어올린다. 기도개방 후 귀와 턱이 수직으로 일직선이 되도록 한다. 5. 호흡 유무 확인(3~5초 동안) 기도개방을 유지한 상태에서 자기의 뺨과 귀를 환자의 코와 입 가까이 대어 내쉬는 숨을 느껴보고, 눈으로는 가슴의 오르내림을 살펴보고, 귀로는 호흡하는 소리를 들어보도록 한다. 6. 두 번 충분히 호흡 기도개방을 유지하면서 코를 잡아 막고, 크게 숨을 들어 마시고 입을 크게

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	16 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	벌려 환자와 입술을 완전히 밀착시키고 붙여넣는다.(2~3회 반복) 7. 맥박 확인 경동맥을 눌러 맥박을 5~10초 동안 확인한다. 8. 응급의료기관 연락 9. 구조호흡 실시 맥박은 있으나 호흡이 없을 때 실시, 6항과 같은 방법으로 반복 실시 (성인: 5초 간격으로 12회/1분, 어린이: 4초 간격으로 15회/1분) 10. 맥박 재확인 구조 호흡을 1분간 실시한 후 기도개방이 유지된 상태로 경동맥을 3~5초 동안 재 감지한다. 맥박이 있다면 호흡유무를 관찰하고, 호흡이 없는 경우 구조 호흡을 계속 실시 후 1분 경과 시 맥박, 호흡을 재확인 한다. 확인 중 맥박이 정지된 경우, 즉시 가슴압박을 병행하여 실시한다.
--	---

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	17 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

구분	응급처치 세부요령
인공 호흡 / 심장 마사지	1. 인공호흡 실시요령 1) 입의 인공호흡법 - 머리를 뒤로 젖히고 숨통을 확보하기 위해서 이마를 누르고 있던 손을 떼어 붙여 넣은 공기가 새지 않도록 엄지와 검지로 환자의 코를 잡는다. - 구조자는 숨을 깊이 들이마신 다음 자기 입을 크게 벌리고 새지 않도록 환자의 입 둘레에 덮어 씌워 환자의 가슴이 약간 볼록해질 때까지 숨을 붙여 넣는다. - 다음에는 입을 떼고 환자의 가슴을 보면 저절로 공기를 토해내는 것을 알 수 있다. 이 때에 자기 귀를 입 가까이 가져가면 토해내는 공기의 흐름이나 소리를 느낄 수 있어 인공호흡의 효과를 느낄 수 있다. 동시에 구조자는 신선한 공기를 들며 마셔서 다음 차례의 붙여넣기에 대비하여야 한다. - 인공호흡을 시작 시 최초 숨통 계통의 상태를 확인하기 위해서 조용히 붙여넣고 다음의 세 번을 빠르고 강하게 계속한다. 그 다음에는 5초에 1회(유아나 어린아이의 경우 3~4초에 1회) 인공호흡의 동작을 되풀이 한다. - 직접 입을 대기가 싫을 때에는 환자의 입 위에 손수건을 놓고 그 위에 입을 덮어 숨을 붙여 넣는다. 2) 입, 코의 인공호흡법 - 입의 인공호흡이 곤란한 경우에는 입과 코의 인공호흡을 실시한다. 머리를 뒤로 젖히고 기도 확보를 하기 위해서 목을 밑에서 쳐들고 있던 손을 아래턱으로 옮겨 아래턱을 앞으로 내어 입술을 닫게 한다. - 구조자는 깊이 숨을 들이마신 후 자기 입술로 환자의 코를 덮어 싸듯이 대고 숨을 붙여넣는다. - 환자의 폐로 공기가 들어갈 때의 느낌, 공기가 나갈 때의 가슴과 복벽의 움직임, 소리의 느낌 등은 1)과 같다. 2. 심장마사지 실시요령 인공호흡을 하면서 경동맥을 짚어보아 심장이 멎어 있음이 확인되면 즉시 심장마사지를 실시한다. 심장이 멎고 4~6분 이상 뇌에 혈액이 보내지지 않으면 심장이 다시 움직이기 시작해도 뇌의 활동은 원상으로 회복되지 않는다. 이 경우에는 인공호흡과 심장마사지를 실시하여 심장으로부터

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	18 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	혈액이 공급되도록 해준다. ※ 인공호흡은 시행 방법을 모르거나 꺼려지는 경우 생략 가능								
구분	응급처치 세부요령								
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">심장정지의 확인</th></tr> <tr> <td>- 맥이 짚여지지 않는다.</td><td>- 심장의 박동소리가 들리지 않는다.</td></tr> <tr> <td>- 호흡이 멎는다.</td><td>- 의식이 없어진다.</td></tr> <tr> <td>- 동공의 열림 등을 볼 수 있다.</td><td></td></tr> </table> 1) 구조자가 1명 일 때 구조자가 1명뿐인 경우에는 흉골압박 심장마사지 15회, 숨을 불어넣는 인공호흡(입: 입, 입: 코) 2회를 반복한다. ※ 최초인공호흡(4회)→심장마사지(15회)→인공호흡(2회)→심장마사지(15회) →인공호흡(2회) 반복 2) 구조자가 2명일 때 구조자가 2명인 경우 한 사람은 중단하지 말고 계속 심장마사지를 하고, 다른 한 사람은 5회의 흉골압박 후 1회 비율로 인공호흡을 한다. 이 경우 흉골압박은 1초에 1회의 속도로 하고 5회째의 흉골압박의 힘을 빼는 시점에서 숨을 불어넣기 시작하여 환자가 숨을 다 토해내기를 기다리지 말고 흉골압박을 시작한다. ※ 최초인공호흡(4회)→심장마사지(5회)→인공호흡(1회)→심장마사지(5회) →인공호흡(1회) 반복	심장정지의 확인		- 맥이 짚여지지 않는다.	- 심장의 박동소리가 들리지 않는다.	- 호흡이 멎는다.	- 의식이 없어진다.	- 동공의 열림 등을 볼 수 있다.	
심장정지의 확인									
- 맥이 짚여지지 않는다.	- 심장의 박동소리가 들리지 않는다.								
- 호흡이 멎는다.	- 의식이 없어진다.								
- 동공의 열림 등을 볼 수 있다.									
지혈	1. 직접 압박 거즈나 깨끗한 헝겊을 두겹게 접어 상처에 대고 붕대로 단단히 감아준다. 2. 지압점 압박 동맥손상 시 지압점압박을 병행하는데 손상된 곳과 심장 사이의 동맥을 뼈에 압박함으로써 출혈을 막을 수 있다. - 팔 지압점: 앞통부분(상박동맥)을 손아귀로 쥐는다. - 하지 지압점: 서혜부 중간에서 대퇴동맥을 골반에 향하여 손바닥으로 압박 - 두부 지압점: 귀 앞에서 두개골을 향하여 측두 동맥을 압박 - 안면 지압점: 턱밑, 동맥이 하악골을 건너간 부분을 향하여 압박 3. 지혈대 사용 직접 압박과 지압점 압박으로 출혈을 막지 못하는 경우에 사용한다. 지혈대는								

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	19 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	폭이 5cm 정도 되는 띠를 사용해야 하며 상처와 가장 가까운 곳에 압박하여야 한다. 지혈대를 맨 곳은 외부에서 잘 보이도록 노출시켜야 하며, 지혈대에 압박을 시작한 시간을 기록하고, 지체 없이 병원 이송 후 의사의 지시에 따라 지혈대를 풀어준다.
구분	응급처치 세부요령
상황 별 후송 절차	1. 들것이 있을 경우 - 환자를 들것에 옮기는 데는 최소한 세 사람이 필요하다. - 환자의 어깨 쪽, 허리 쪽, 무릎 쪽에 한 사람씩 무릎을 꿇고 앉는다. - 세사람이 동시에 머리,어깨,등,허리,다리에 손바닥을 위로하여 손을 놓는다. - 한사람이 "들어"라는 구령에 따라 동시에 들어서 들 것 위에 올려놓는다. - 들것은 4인이 함께 들어서 안전하게 이동하는 것이 좋다. ※ 주의사항 - 환자 수송 시 환자의 발목을 앞으로 하여 걷는 것이 원칙이지만 언덕, 계단을 오를 때에는 머리를 앞으로 하여 운반하여야 한다. - 구급차에 실을 때는 머리를 앞쪽으로 향하게 한다. 2. 들것이 없을 경우 - 들것이 없는 경우에는 사람이나 물건을 이용하여 후송한다. - 일반 환자의 경우에는 업어서, 안아서, 부축해서, 앉혀서 후송할 수 있다. - 골절, 복부손상, 두부손상 환자는 몸을 구부리거나 일으켜 세우지 말아야 하므로 여러명에서 운반해야 한다. 1) 3인 운반 1번 - 환자를 들것에 실을 때와 동일하게 한다. - 환자의 가슴과 운반인의 가슴이 서로 맞닿게 하여 앞으로나 옆으로 운반한다. 2) 3인 운반 - 환자를 중앙에 두고 한쪽에 두 사람, 반대쪽에 한 사람이 각각 무릎을 꿇고 앉는다. - 손등을 아래로, 손바닥을 위로 하여 환자 몸 밑으로 놓는다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	20 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별첨 제 2호. 환자 상태별 응급처치 요령)

상태	주요증상	응급처치 요령
충격 (쇼크)	- 얼굴 창백. - 식은 땀, 메스꺼움, 헛구역질 - 빈맥, 약한 맥박 - 호흡의 불규칙(얕은 호흡) - 의식소실	- 자세 : 머리에 부상이 없을 경우 하체를 20~30cm 높여준다. : 가슴부상으로 호흡이 힘들 경우 머리와 어깨를 높인다. - 보온 : 담요, 옷 등으로 덮어준다. - 음료 : 의식이 있는 시 더운물, 차 등을 조금씩 마시게 한다. : 의식이 없을 시, 수술을 요하는 경우 거즈에 물을 적셔 입언저리에 댄다.
창상 (상처)	- 종류 : 찰과상 피부나 점막이 마찰되 거나 긁힌 상처 - 절창: 날카로운 물체에 의하여 베어진 상처 - 열창: 둔한 물건에 타박 또는 압박으로 조직의 파괴를 초래함 - 자창: 찢리거나 조직을 뚫고 나간 상처	- 출혈이 심하지 않은 경우 : 엉키어 뭉친 핏덩어리는 떼어내지 말아야 한다. - 흙이나 더러운 것이 묻었을 때는 깨끗한 물로 상처를 씻어준다 - 소독된 거즈를 상처에 대어주고 의사의 치료를 받게 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	21 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	- 위험성 : 감염 위험 : 출혈 1,000cc(20%) 출혈: 생명 위험 1,500cc(30%) 출혈: 생명 잃음	- 출혈이 심한 경우 : 즉시 지혈을 하고, 출혈 부위를 높게 하여 안정 되게 놓는다. : 수술을 대비하여 출혈이 멎기 전에는 음료를 섭취 시키지 않는다.
--	--	--

상태	주요 증상	응급처치 요령
특별히 주의할 상 처	- 자창 : 상처소독이 용이하지 않다 : 파상풍균의 번식 위험이 있다.	- 파상풍균 예방주사 맞아야 한다.
	- 감염창 : 감염 2~3일후 증상이 나타난다 : 상처부위 발열, 곪음, 발적 : 서혜부(하지), 액와(상지) 두부 (경부) 임파선이 붓는다..	- 안정 후 감염부위를 거상한다. - 생리식염수를 상처부위에 대고있는다 - 신속한 의사진찰을 격려한다.
	- 이물상처 : 나무, 유리조각이 박힌 경우	- 이물이 표면 가까이 있는 경우 : 이물을 빼내고 소독한다. - 이물이 깊이 박혀있는 경우 : 제거하지 말고 의사진찰을 받는다

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	22 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	- 안검 및 안구의 상처 : 이물질이 들어간 경우 : 안검 및 그 주위 조직의 상처 : 눈의 화상, 안구의 상처	- 흐르는 물에 씻거나 깨끗한 형궤를 식염수나 물에 적신 후 닦아 낸다. - 의사진료전에 화상 입은 곳을 깨끗한 형궤로 느슨하게 드레싱 한다. - 산, 알칼리 등의 약물이 눈으로 튀어 들어간 경우 물, 우유로 즉시 씻어낸다.
	- 내부출혈 : 위_토혈, 흑색변, 메스꺼움, 빈맥 : 폐_객혈, 가슴통증, 빈맥 : 장_복통, 혈변, 빈맥, 어지럼증 : 심할 시 의식소실, 심정지	- 빨리 의사의 진료를 받는다.. - 반듯이 눕히고 마실 것은 주지 말고 기침을 하거나 구토 시 고개를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 방지한다. - 상처를 심장보다 낮게 위치해 쇼크에 대한 응급처치를 실시한다. - 내장이 밖으로 빠져 나왔을 경우 : 식염수에 적신 깨끗한 형궤으로 내장을 잘 감 싸 마르지 않게 한 후 병원으로 후송한다.

상태	주요증상	응급처치 요령
골절 탈구 염좌	- 골절 : 단순골절_뼈만 손상 : 복합골절 부러진 뼈 끝이 피부를 뚫어 창상이 겹치고 혈관손상으로 심한 출혈과 쇼크 동반	- 복합골절 : 출혈 시 직접압박하여 지혈한다. 피가 멈춘 후 붕대를 감아 고정한다. : 부목사용하여 환부를 고정한다. - 운반요령 : 부목으로 고정 후 옮기며 업지않는다 : 부러진 뼈를 맞추려 하지 말고 쇼크에 대한 응급처치를 시행한다
	- 탈구 : 통증이 심하며 육안상 부어오르게 보이며 움직임 제한이 있다	- 병원으로 후송하여 의사진료를 받는다. - 편한 자세 및 환부 냉찜질을 한다.
	- 염좌	- 환부를 높이고 고정, 냉찜질을 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	23 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

화상	- 1도화상: 피부가 붉어짐 - 2도화상: 물집 생김 - 3도화상: 신경 및 조직파괴 - 햇빛화상: 1도 혹은 2도 화상	- 환부를 흐르는 찬물에 대고 있다. - 상처에 탈지면을 직접 대지 않는다. - 상처에 붙어있는 물질을 떼지 않는다
	- 약품 화상 : 신체 조직손상도 큼	- 약품이 묻은 의류는 벗고 물로 씻는다. - 알칼리성 약품일 경우 우유로 씻는다. - 즉시 병원으로 후송한다.
	- 열사병	- 서늘한 곳으로 옮긴 후 눕히고 머리에 찬물이나 얼음주머니를 대준다. - 의식 없을 시 즉시 병원으로 이송한다
협착절단	- 심부조직 노출 : 손상부위 출혈량 증가 : 쇼크증상 발생 (빈맥, 호흡과다, 의식소실, 창백 등)	- 사고장소에서 안전한 장소로 이송한다. - 출혈방지위해 환부를 높이고 고정한다. 지혈점 압박 후 병원으로 이송한다.
전기감전	- 쇼크에 의해 심정지, 의식소실, 전신마비 증상이 나타난다. - 전기가 통한부위 상처가 생기며 특히 출구 상처는 깊고 심하다.	- 전기차단하고 안전한 장소로 옮긴다. - 심폐소생술을 시행한다. - 즉시 병원으로 후송하여 치료한다.

상태	주요증상	응급처치 요령
추락 낙하물 교통사고	- 척추 손상 : 두부 및 안면 손상 시 척추 손상으로 간주한다. : 팔, 다리가 움직이지 않으며 감각이 둔해진다	- 환자의 이동을 금하고 구급대가 올 때까지 기다린다.
	- 두부 손상 : 열상, 뇌진탕, 뇌출혈, 의식 저하 등 : 불규칙적 호흡 및 빈맥 : 좌우 동공크기 다르거나 동공	- 경추 손상이 아닐 시 머리와 어깨를 높여 호흡을 돕는다. - 출혈 시 소독 거즈로 압박지혈을 한다. - 쇼크 방지를 위해 보온하고 즉시 병원으로 후송한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-019(5)
	현장 응급처치 관리 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	24 / 24
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

	반응 소실 : 코, 귀, 입에서 출혈	
--	-------------------------	--